

15. FACE : DVT DE LA LANGUE ET THYROÏDE

DURÉE : 07:43

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore les processus complexes de développement de la langue et de la thyroïde au cours de l'embryogenèse, en mettant l'accent sur le redressement embryonnaire et ses implications sur la dynamique posturale. Les pratiques telles que la stabilisation de la langue et l'interaction avec le cartilage thyroïdien sont abordées, soulignant l'importance des structures entourant le foramen sécum. Les enseignants examinent également l'impact des arcs branchiaux et des tissus embryonnaires sur le développement global, ainsi que l'importance des fulcrums dans le corps, notamment à travers le bassin. Ces concepts sont cruciaux pour les praticiens cherchant à intégrer une approche holistique dans leur travail ostéopathique.

DÉVELOPPEMENT DE LA LANGUE ET DE LA THYROÏDE

Au moment de la **flexion** et du **redressement** de l'embryon, le tube digestif est initialement positionné assez bas. En observant le **palais**, on remarque qu'il présente une forme ogivale, alors qu'auparavant, il était plutôt bas. Ce redressement s'accompagne d'une **descente des ptérigoïdes** et d'une traction qui fait monter le tube digestif.

Ce processus de développement est crucial pour la formation de la **langue** et de la **thyroïde**, qui provient de la langue. Dans la coupe embryonnaire, on observe la partie **endodermique** ainsi que les arcs pharyngiens numérotés (1, 2, 3, 4). Dans l'arc pharyngien numéro 1, au moment du redressement, apparaît la **couche de la langue latérale**. Entre l'arc branchial numéro 2 et cette couche, se forme un **tuberculum impair** et un petit trou, le **foramen sécum**.

Le foramen sécum, qui se développe avec la langue, est essentiel pour la formation du système thyroïdien.

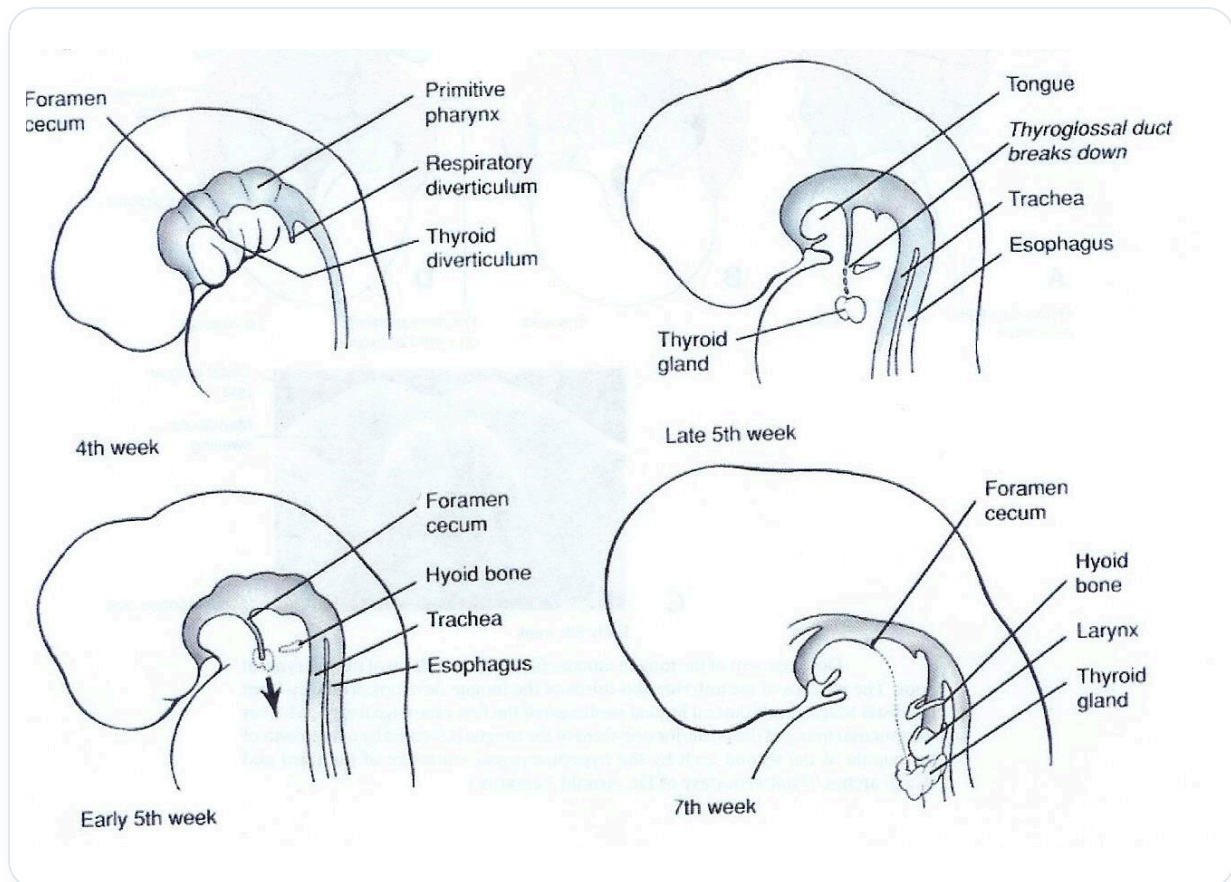


FIG. — Développement thyroïdien embryonnaire

Ce développement est marqué par une **croissance globale**, avec un point fixe qui agit comme un point d'appui. La profondeur de la langue est liée à la **profondeur de l'encéphalisation**.

Le redressement embryonnaire révèle le foramen sécum, qui est crucial pour la formation des structures environnantes. Une autre coupe montre le **cartilage de Meckel** et la langue. Il est important de noter que les flèches dans les illustrations doivent être orientées correctement pour comprendre la dynamique de ce développement.

Il existe un déchirement entre la langue et le diaphragme, où le **cartilage thyroïdien** devient un point d'appui. Stabiliser la langue et l'air vague est essentiel pour maintenir l'équilibre au niveau du cartilage thyroïdien et de l'os hyoïde. La langue joue un rôle fondamental dans l'activité posturale, et l'enfant commence à se redresser avec l'apparition de ses premières dents, utilisant sa langue comme point d'appui.

La langue cherche à **boucher les petits trous** lors de la déglutition, et son mouvement peut influencer l'axe longitudinal du corps, allant jusqu'au **bassin**. Des déviations du bassin peuvent être le reflet d'un déséquilibre occlusal, lié à la dynamique linguale.

Les dents sont des zones de **densification** et peuvent conserver des mémoires, ce qui influence la dynamique corporelle. Dans cette phase de développement, on observe également les **tonsils palatins**, la **parathyroïde**, le **thymus**, et le **corps ultimo-branchial**. Chaque arc branchial (mandibulaire, thyroïdien, laryngé supérieur et inférieur) est interconnecté, et le tissu endodermique joue un rôle central dans cette dynamique.

Le développement embryonnaire se déroule sur une période spécifique, avec la **fermeture du tube neural** au 27ème jour et le redressement complet de l'embryon après le premier mois. La formation de l'embryon est achevée entre le deuxième et le troisième mois, avec des structures bien définies.

Les tissus embryonnaires s'influencent mutuellement : l'**ectoderme** et l'**endoderme** dépendent du **mésoderme**, qui assure la transmission des informations nutritives. Cette dynamique est essentielle pour comprendre le développement de la langue, de la thyroïde et de la parathyroïde.

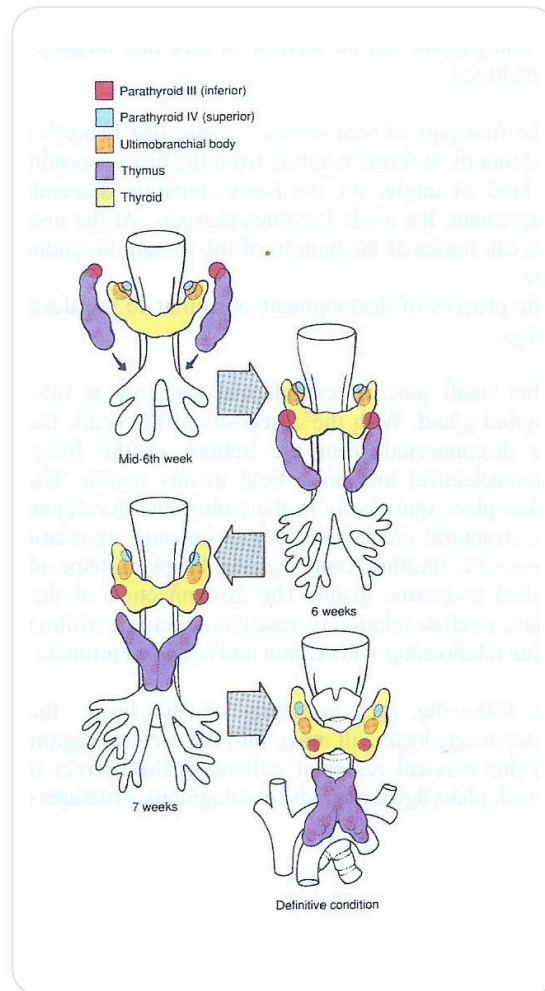


FIG. — Développement thyroïde et parathyroïde

Il est crucial de suivre les **fulcrums** dans le corps, car ils se manifestent dans la pratique. Le **nombril** est un grand fulcrum, et il est essentiel que le bassin soit dégagé et libre pour un bon fonctionnement. Dans la pratique ostéopathique, le traitement du bassin est souvent une priorité, car il est lié à la **symphyse phénobasilaire**. Travailler sur le sacrum ou le bassin influence directement cette symphyse, permettant ainsi une approche holistique du corps.

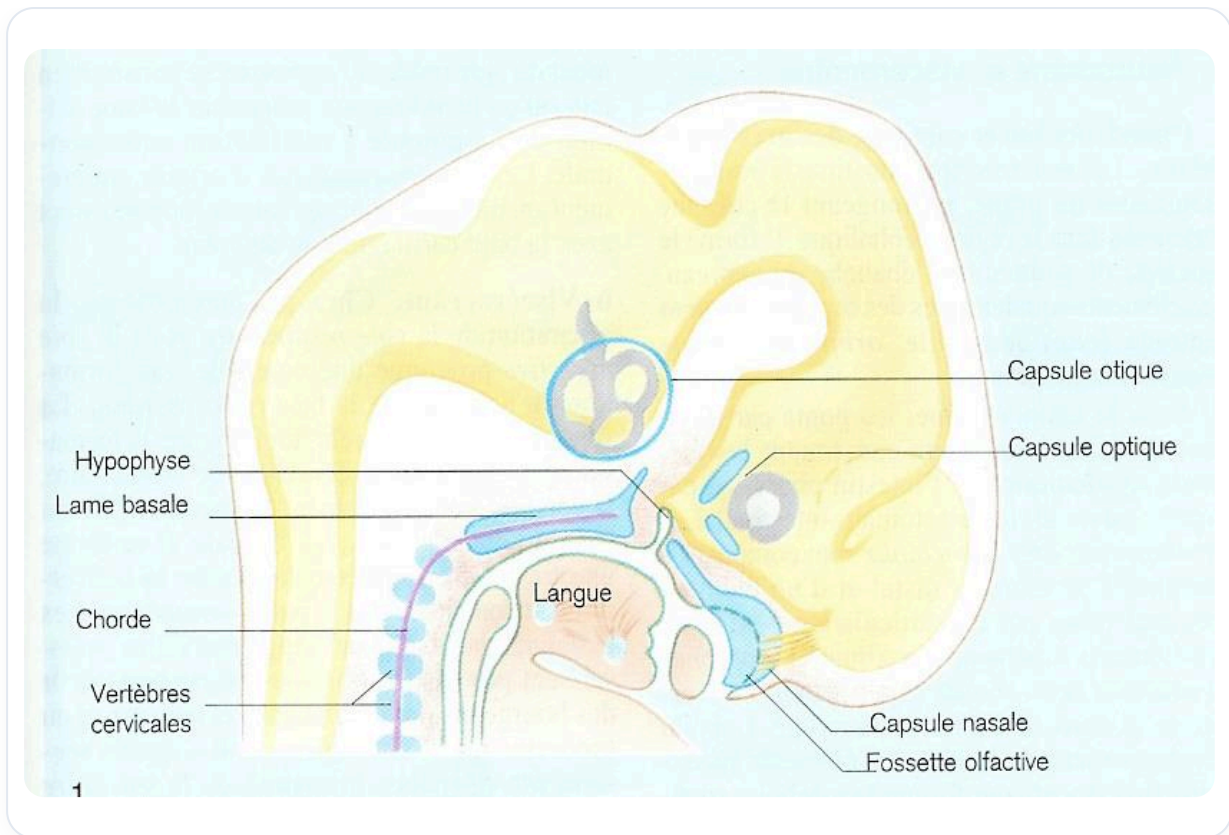


FIG. — *Embryon humain sagittal*

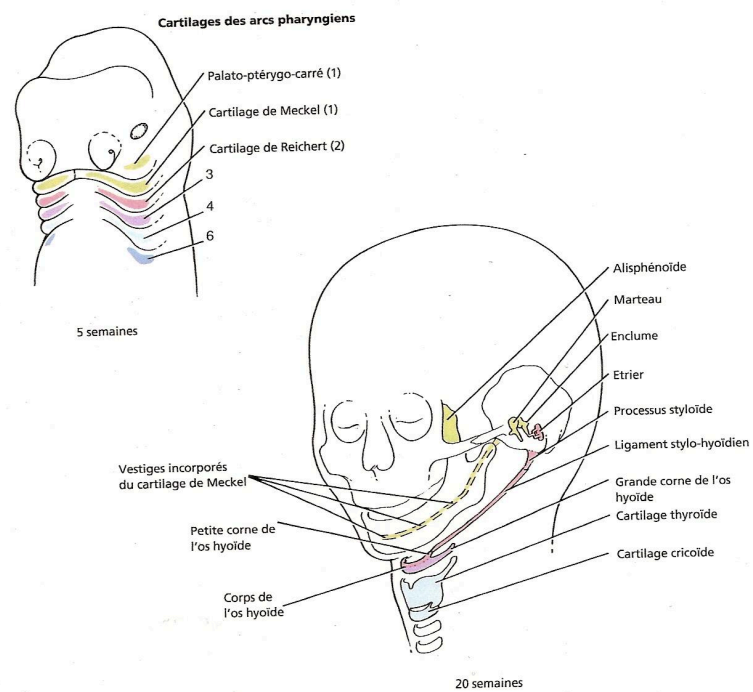


Fig. 12 - 5. Devenir des cartilages des arcs pharyngiens. Ces cartilages donnent un petit os de l'orbite, les éléments squelettiques des mâchoires, les trois osselets de l'oreille, l'os hyoïde et le squelette du larynx.

FIG. — Développement arcs pharyngiens

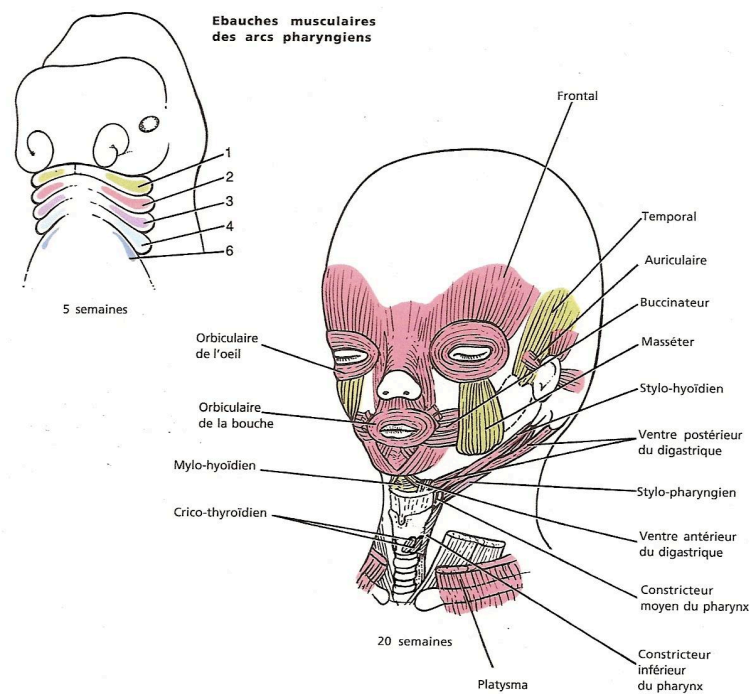


Fig. 12 - 7. Devenir de la musculature des arcs pharyngiens. Les muscles des arcs pharyngiens se développent à partir du mésoblaste para-axial qui se constitue principalement à partir des somitomères crâniens et des somites occipitaux. Les myoblastes du sixième arc fournissent la musculature intrinsèque du larynx (non représentée).

FIG. — Musculature arcs pharyngiens

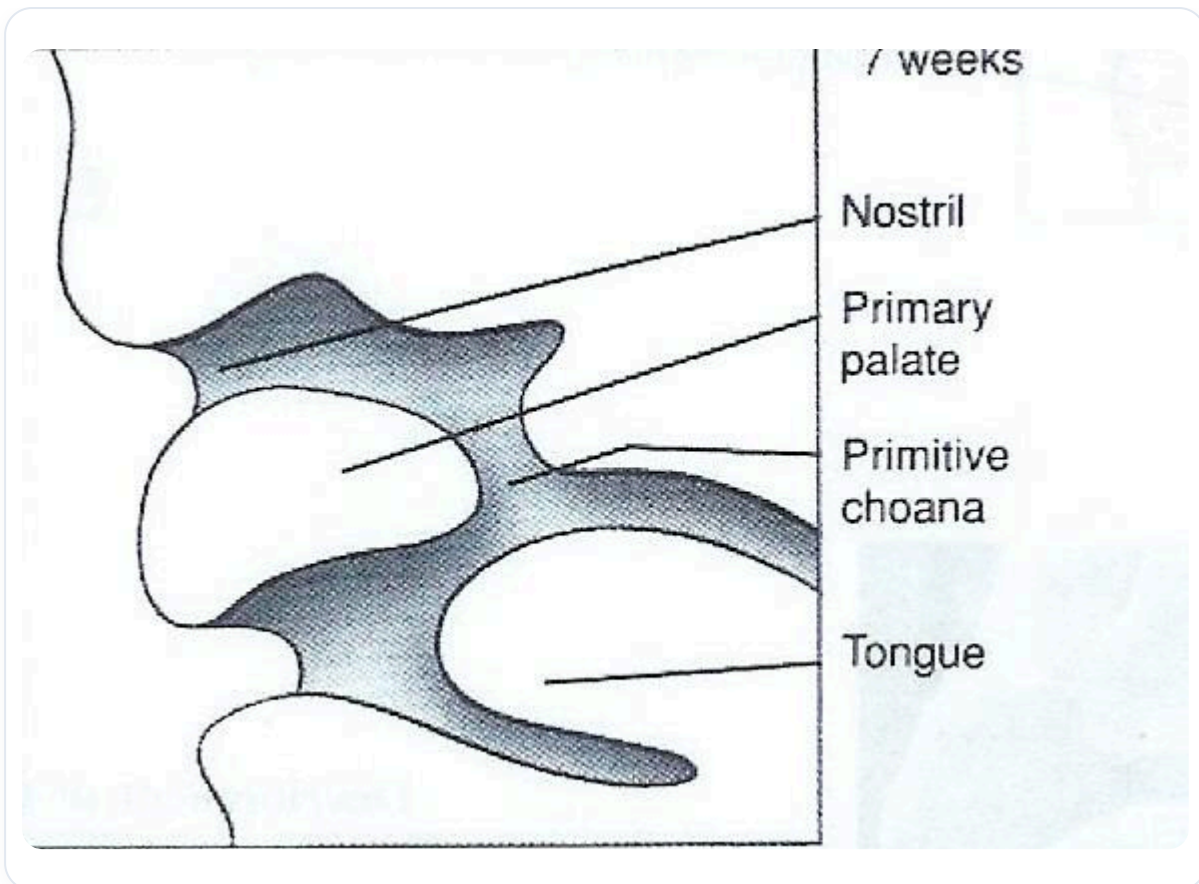


FIG. — Développement palais embryon

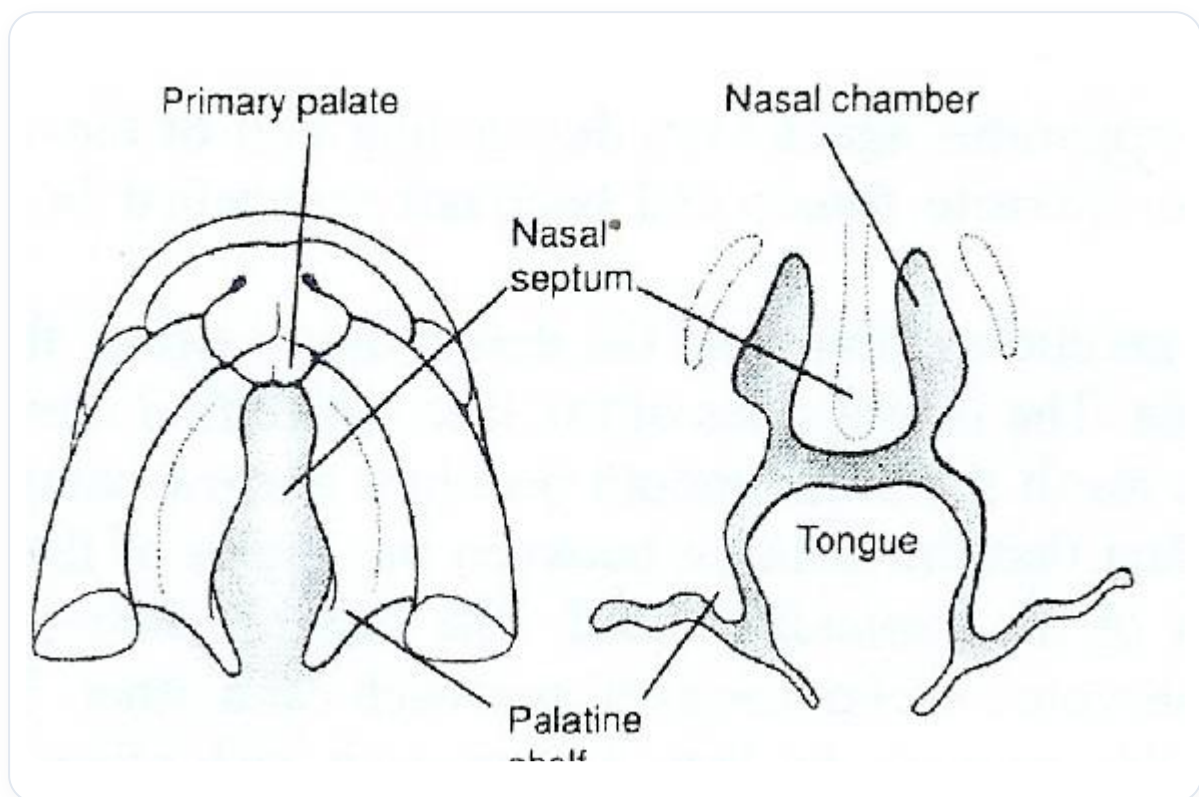


FIG. — Développement palais et nez

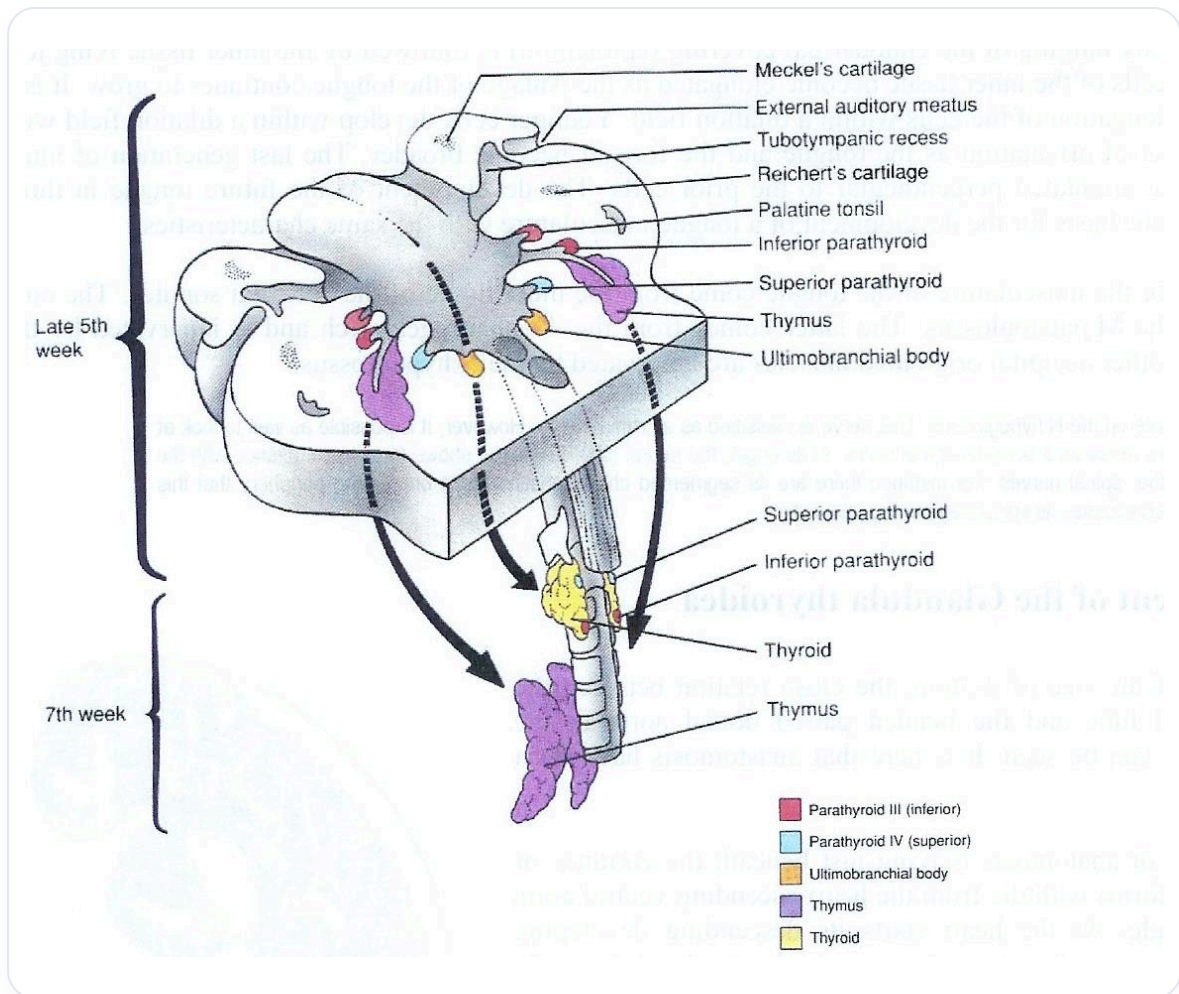


FIG. — Développement pharyngien